



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91
E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Зкладам охорони здоров'я
(за списком)

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) висловлює свою повагу та надає роз'яснення щодо застосування додаткових коригуючих коефіцієнтів та правил обліку деяких інтервенцій в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Повідомляємо, що відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 р. № 1503 (далі - Порядок), НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391, та умовам закупівлі, якщо інше не визначено Порядком, на підставі поданих пропозицій про укладення договорів відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410.

Відповідно до Порядку тариф на медичні послуги за лікування пацієнтів за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», що передбачені відповідними специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 8735 гривень.

Відповідно, оплата відбуватиметься за надані медичні послуги на підставі інформації, яку внесено до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення відповідного звітного періоду.

Щодо застосування додаткових коефіцієнтів та принципу оплати послуг за пакетами «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Зазначаємо, що для оплати пролікованого випадку за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» будуть застосовуватись такі коефіцієнти:

- 1.1. **Коефіцієнт 1,3** – за **готовність** надавати медичну допомогу **дітям** за умови укладення договору на додаткові умови пакету.
- 1.2. **Коефіцієнт 1,2** – за **готовність** надавати медичну допомогу **дорослим** за умови укладення договору на додаткові умови пакету.
- 1.3. **Гірський коефіцієнт 1,2** – за послуги, які надані в місцях надання медичних послуг, що розташовані у населених пунктах, яким надано



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 4092/6-15-25 від 28.01.2025
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007866330044EAD800
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 13.09.2024 00:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

статус гірських згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

- 1.4. **Коефіцієнт 1,1** – за надання пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям для ДСГ з переліку *Додатку 1* та надавачів медичних послуг, визначених переліком МОЗ.
- 1.5. **Коефіцієнт 0,6** – для пролікованих випадків з тривалістю лікування 5 діб та менше, для ДСГ з переліку *Додатку 2*.
- 1.6. **Відповідні коефіцієнти** – за умови виконання двох або більше операцій (множинні або чисельні операції в рамках одного пролікованого випадку), що включені до відповідних діагностично-споріднених груп, відповідно до *Додатку 3*. До ДСГ E01 включено тільки інтервенції зазначені у *Додатку 4*. Даний коефіцієнт застосовується для надавачів медичних послуг, які мають коефіцієнт пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям, за переліком МОЗ.
- 1.7. **Коефіцієнт 1,2**, який множиться на коефіцієнт відповідної ДСГ – за умови виконання хірургічних втручань, пов’язаних з виконанням інтервенцій (*Додаток 5, Додаток 6*), визначених алгоритмами та правилами НСЗУ, за пакетом медичних послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” (застосовується для надкластерних закладів охорони здоров’я, закладів Національної академії медичних наук, Національної академії наук, Державного управління справами, МОЗ).
- 1.8. **Коефіцієнт 0,343** від базової ставки – за умови проведення діалізу при гострих станах (без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування за пролікований випадок), який множиться на глобальну ставку та кількість діб, коли проводився діаліз.
- 1.9. Коефіцієнт за лікування пацієнтів в умовах відділення **інтенсивної терапії (ВІТ)** або відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ), зокрема:
 - коефіцієнт **0,1** (за одну добу лікування упродовж перших 7 діб лікування у ВІТ/ВАІТ) для надкластерних закладів охорони здоров’я; закладів охорони здоров’я державної форми власності;
 - коефіцієнт **0,05** (за одну добу лікування упродовж перших 7 діб лікування у ВІТ/ВАІТ) для кластерних закладів охорони здоров’я.

Зазначаємо, що вказаний коригувальний коефіцієнт додається до коефіцієнту усіх ДСГ, крім ДСГ з переліку *Додатку 7*.

Щодо обліку в ЕСОЗ сеансів з гемодіалізу

При створенні виписки стаціонарного лікування пацієнта, якому проводилися сеанси з діалізу, в інтервенціях потрібно вказувати відповідний код з нижче вказаного переліку:

- 13100-00 Гемодіаліз;
- 13100-01 Інтермітуюча гемофільтрація;
- 13100-02 Постійна гемофільтрація;
- 13100-03 Інтермітуюча гемодіафільтрація;

- 13100-04 Постійна гемодіафільтрація;
- 13100-05 Гемоперфузія;
- 13100-06 Перитонеальний діаліз, короткостроковий;
- 13100-07 Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий;
- 13100-08 Постійний перитонеальний діаліз, довгостроковий.

Також у виписку потрібно вкласти ЕМЗ «Спостереження» (код 87238-2 Примітка про діаліз), в якому вказати кількість діб, коли проводилися сеанси діалізу. Акцентуємо вашу увагу на тому, що вказувати потрібно саме кількість діб, а не кількість сеансів.

Наголошуємо на таких важливих моментах обліку.

1. Сеанси діалізу потрібно обліковувати у виписках: а) пацієнтів, у яких ниркова недостатність розвинулась гостро, і пацієнту до цього пролікованого випадку сеанси гемодіалізу не проводилися; б) пацієнтів, в яких є хронічна ниркова недостатність, що потребує застосування сеансів хронічного діалізу, і в яких виник гострий стан. Процедури з гемодіалізу обліковувати у випадку проведення сеансів діалізу персоналом та на обладнанні надавача, де пацієнт отримує стаціонарне лікування. Якщо пацієнту процедури гемодіалізу проводили спеціалісти з іншого закладу на своєму обладнанні, то вони їх і обліковують. У випадку наявності в ЕСОЗ одночасно виписки зі стаціонару із кодами діалізу та спостереження, а також ЕМЗ в межах пакетів «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах» в той самий період, коли пацієнт отримував стаціонарне лікування, пролікований випадок буде потрапляти у звіт надавача, який облікував сеанси діалізу в стаціонарній виписці.
2. Основним діагнозом потрібно зазначати гострий стан, з приводу чого пацієнт госпіталізований у стаціонар, при цьому гостра ниркова недостатність зазначається в ускладненнях, а хронічна – у супутньому діагнозі.

Коефіцієнт за умови проведення **діалізу** при гострих станах розраховується для пролікованих випадків, про які прозвітували лікарі закладів з переліку МОЗ, відносно яких застосовується коефіцієнт пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям (без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування за пролікований випадок).

Щодо обліку в ЕСОЗ пролікованих випадків із лікуванням пацієнтів в умовах ВІТ або ВАІТ

У виписку стаціонарного лікування пацієнта, який отримував лікування в умовах ВІТ/ВАІТ, потрібно вкладати ЕМЗ «Спостереження» з кодом 74200-7 «Тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії», в якому потрібно вказати кількість діб, коли пацієнт отримував лікування у ВІТ/ВАІТ. Зазначасмо, що потрібно вказувати коректну інформацію щодо тривалості лікування пацієнта в умовах ВІТ/ВАІТ, оскільки ґрунтуючись на ній розраховуються тарифи та референтні значення тривалості лікування у ВІТ/ВАІТ при розробленні Програми медичних гарантій на 2026 рік.

Розрахунок кількості пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції у ВІТ/ВАІТ. Даний показник розраховується як частка стаціонарних взаємодій із закодованими інтервенціями ШВЛ (Додаток 8), до загальної кількості стаціонарних взаємодій, в яких вкладено спостереження з кодом 74200-7.

Щодо обліку оперативних втручань, виконаних лапароскопічним, артроскопічним або ендоскопічним методом пацієнтам за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Відповідно до австралійських стандартів кодування та національного класифікатору медичних інтервенцій НК 026:2021 (далі - НК 026:2021), у разі проведення хірургічного втручання лапароскопічним, артроскопічним або ендоскопічним методом, але відсутності потрібного коду, який би охоплював одночасно і лапароскопію, і саму процедуру, в НК 026:2021, слід кодувати обидві процедури.

ПРИКЛАД

Лапароскопічна гепатектомія.

Перша вказана процедура: Код 90346-00 Тотальна гепатектомія

Супутня процедура: Код 30390-00 Лапароскопія.

У разі наявності коду, що охоплює одночасно і ендоскопію/лапароскопію/артроскопію, і саму процедуру, в НК 026:2021 слід зазначати саме такий код.

ПРИКЛАД 1

Лапароскопічна спленектомія Код: 31470-00.

Пріоритет діяльності НСЗУ – ефективна реалізація програми медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів, щоб кожен мав доступне та належне лікування.

Працюємо разом заради Перемоги України та здоров'я наших людей!

Додаток 1: на 3 арк., в 1 прим.

Додаток 2: на 5 арк., в 1 прим.

Додаток 3: на 2 арк., в 1 прим.

Додаток 4: на 1 арк., в 1 прим.

Додаток 5: на 2 арк., в 1 прим.

Додаток 6: на 5 арк., в 1 прим.

Додаток 7: на 1 арк., в 1 прим.

Додаток 8: на 1 арк., в 1 прим.

Голова

Наталія ГУСАК



Олена Ковальова 044 290 06 91

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст відділу контролю,
документального забезпечення
та архіву
Л. Рокітська Христина

28.01.2025